EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 79253
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-19 13:01:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ANGELICA ESPINOZA PINO			RUN	: 5.474.527-3
F.Nac	: 02-02-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-02	Fecha Egreso	: 2024-02-19 13:01:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G45.8-OTRAS ISQUEMIAS CEREBRALES TRANSITORIAS Y SINDROMES AFINES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Infarto extenso ACM derecha. Oclusión ACI terminal y M1 derecha. ATE
- Oclusión trombótica tronco braquiocefálico/subclavia derecha
- Antecedentes: - Hipertensión arterial - Hipotiroidismo - Dislipidemia - Diabetes mellitus tipo 2 NIR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes mórbidos:
- Hipertensión arterial
- Hipotiroidismo
- Dislipidemia
- Diabetes mellitus tipo 2 NIR

Antecedentes quirúrgicos:
- Histerectomia/Colecistectomia

Alergias:
- Lidocaina?

Medicamentos:
- Atorvastatina 40 mg, 1 comp al día
- Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día
- Levotiroxina 100 mcg, 6 comp por semana
- Losartan 50 mg, 1 comp al día
- Metformina 500 mg, 1 comp al día

Habitos:
- OH (-)
- Tabaco (-)
- Drogas (-)

Social:

- Dueña de casa 86012941

Diestro mRS 1
Consulta el 02/02/24 por cuadro de inicio a las 10 horas consistente en asimetría facial y debilidad en HC derecho, con regresión parcial durante horas posteriores. Ingresa con FC 81 lpm, PA 210/90 mmHg, T° 36.3°C, Sat 95%, HGT 193 mg/dL. Al examen neurológico se constata solo discreta disartria, angioTC de cerebro y cuello con suboclusión ACI derecha y estenosis severa ACI izq. A las 18:15 horas con deterioro neurológico respecto a evaluación previa asociado a somnolencia. Se reconsulta a neurologo de turno en HHM, con NIHSS 19 puntos, se mantiene esquema de tratamiento y se desestima terapia de reperfusión, se controla con nuevo TC de encéfalo sin contraste en que no se constatan complicaciones hemorrágicas. Se presentpo caso a HGGB y se desestima reperfusión mecánica por no disponer de acceso cervical para trombectomia mecánica de segmento M1 derecho. Se indica hospitalización en UPAC para seguimiento por neurología.
Se toma conocimiento el 05/02/24 del caso, paciente de cuidado en buenas condiciones generales, afebril, con hemodinamia normal. Sin apremio ventilatorio y sin otras molestias. Sin cefalea, solo refiere dolor escaso coxal izquierdo.

Neurológico:
Progresa de manera favorable, en el estudio se estima posible embolia arterio-arterial secundaria a estenosis suboclusiva de tronco braquiocefálico derecho con efecto hemodinámico en extremidad superior derecha. Se solicita ecocadiograma TT que se encuentra pendiente de realizacion previo a hospitalizacion domiciliaria.
En cuanto a la rehabilitación con buen rendimiento en alimentación por via oral, y bipedestación con asistencia de 2 operadores.

Cirugía:
En estudio se constató estenosis suboclusiva tronco braquicefálico con compromiso de subclavia. Se solicitó evaluación por cirugía quienes consideran necesidad de control por cirugía vascular. Se solicitó compra de servicio autorizado por subdirección médica, el que se encuentra pendiente de concretar al momento del alta. Se inició doble antiagregación ASA y Cilostazol.

Considerando evolución clínica, funcionalidad actual, y rehabilitación. Se plantea en conjunto con cirugía y familiar, derivación a hospitalización domiciliaria para continuar rehabilitación en espera de evaluación por cirujano vascular.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo levantar y pasar a sillón en forma diaria.
2. Régimen hiposódico consistencia papilla a tolerancia. Agua por boca 250 cc por 3 veces.
3. Omeprazol 20 mg al día
4. Aspirina 100 mg, 1 cop al día, VO
5. Cilostazol 100 mg, 1 comp cada 12 horas VO
6. Atorvastatina 40 mg, 2 comp al día, VO
7. Levotiroxina 100 ug, 1/2 comp al día, VO
8. Losartan 50 mg, 1 comp cada 12 horas, VO
9. Amlodipino 10 mg, 1/2 comp. VO
10. Hidroclorotiazida 50 mg, 1 comp al día, VO
11. Clotrimazol aplicar cada 12 horas en región inguinal
12. Kinesioterapia motora
13. Terapia fonoaudiológica
14. Terapia ocupacional.
15. Vigilar perfusión y pulsos de extremidad superior derecha.
16. Pendiente informe de ecocardiograma TT realizado al alta
17. Control GES ACV en 10 días HSC
18. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 19/02/24 Glic 118, Creat 0.6, MDRD 96, Uremia 42, ELP 134/4.1/99, Hb 13.4, Hto 39.4, Leuco 10000, Plaq 197.000, VHS 32. PCR 22.7
- 14/02/24 Glic 126, Alb 3.7, Creat 0.6, MDRD 96.9, Uremia 35, BUN 16, ELP 137/4.1/101, Hb 14.1, Hto 40.4, leuco 8100, plaq 289.000, VHS 51, PCR 20.6. Procalc 0.03.
- 12/02/24 angioTC de extremidad superior derecha: Estenosis ateromatosa severa del 90% en tronco braquiocefálico derecho que se extiende a subclavia y carotida comun derecha con estenosis del 60%
- 10/02/24 Creat 0.6, MDRD 96.94, ELP 138/3.9/103, PCR 52.5, Procalc 0.03
- 09/02/24 Glic 121 creat 0.6 ELP 140/4.1/104 PCR 63.8 calcio 9.1
- 06/02/24 ColT 118, HDL 31, LDL 60, TGL 134. Tropo 8, TSH 1.92, T4L 0.96, VitB12 932, HbA1c 6.2
- 06/02/24 TC de encéfalo sin contraste: consolidación de hipodensidad isquémica frontooperculoinsular y parietooccipital derecha. Sin transformación hemorrágica.
- 05/02/24 Creat 0.6, MDRD 96.9, Uremia 41, BUN 19, ELP 142/4.0/103, Hb 15.4, Hto 44.9,Leuco 10400, Plaq 265.000, VHS 48. PCR 20.5.
- 02/02/24 Glic 173, Creat 0.6, MDRD 96.9, Uremia 36, ELP 141/4.6/101, Hb 13.9, Hto 39.9, Leuco 5500, plaq 258.000, PCR 17.3, Lactato 2.3. LDH 293. INR 1.14
- 02/02/24 angioTC de cerebro y cuello: estenosis suboclusiva de T braquicefalico, subclavia, carotida comun y ACI derecha desde emergencia. oclusión M1 derecha

OBSERVACIONES:

Examen neurológico al alta:
Neurológico:
- Mental: Vigil, OTE, atenta, sin alteración lenguaje, disartria leve
- PC: Pupilas isocoricas, RFM +/+, CV normal. OCM normal. Hipoestesia facial izquierda, PFC izquierda. Protruye lengua en linea media
- Motor: Hemiparesia izquierda braquial M0, crural M2, cutáneo plantar extensor izquierdo
- Sensitivo: Hipoestesia BC izquierda predominio crural.
- Cerebelo: Coordinación HC derecho normal
- Signos meníngeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO